

RESUME SKILLS

1. BASIC LIFE SUPPORT

1. Assurer la **securité** (celle du blessé et la sienne)
2.
 - a) Evaluer la **reactivité** du blessé, son **état de conscience**,
 - > l'appeler (Monsieur, Madame!)
 - > le stimuler (secouer par les épaules)Si CONSCIENT, position latérale de securité !
 - b) Evaluer sa **respiration** (voir si le thorax bouge, sentir vers la bouche, écouter)
Si NORMALE, position latérale de securité !
3. Appeler à l'**aide**, demander **défibrillateur** ex. Si témoins
4. Appeler le **144** (ou demander à témoin)
 - > Donner toutes les infos (se présenter, quoi, où, qui)
5. **Circulation (C)** -> Si PRO, prendre le **poul** (a. Carotide pendant 10sec)
6. Si **PAS de poul, inconscient, ne respire pas**: Début **massage cardiaque** !
 - Evt ouvrir chemise, enlever lunettes
 - Poser ses mains à la jonction ligne mammaire-ligne sternale
 - 100 compressions de 4-5cm par minute, laisser le thorax se relaxer entre deux compressions
7. Libérer les voies **aériennes (A)**
 - S'assurer qu'elles soient libres (ex. Rien dans la bouche, ...)
 - > Tirer la tête vers l'arrière (en tenant sous menton) = **manceuvre d'Esmarsch**ATTENTION si suspicion trauma cervical ! Ne pas bouger la tête, ni la colonne !
8. **Respiration (B)**
 - si possible 30 compressions, puis 2 ventilations avec mvt thorax 4cm
(bien appliquer masque)
 - si tout seul, compressions uniquement !
 - Limiter les interruptions, mais se relayer toutes les 2mn env.
(sauter 2 ventil si besoin)
9. **Défibrillation (D)** Si indiqué...
 - 1) Mise en route automatique ou bouton
 - 2) Prévenir que le « choc » arrive, s'écarter, regardez autour que personne ne touche
 - 3) Continuer le massage à 100/minute avec evt 2 insufflations tous les 30, le défibrillateur va choquer toutes les 2 mn

2.1.1 Compétences communicationnelles (ELM et sessions pratiques anamnèse et communication = SPAC)

- Instaurer un climat relationnel adéquat.
- Structurer l'entretien.
- Maîtriser les objectifs principaux des différentes étapes de la consultation (prise de contact, recueil des informations, synthèse et planification, clôture de l'entretien)
- Explorer les dimensions psychosociales.
- Explorer le vécu émotionnel du patient d'une façon empathique.

2.1.2 Système cardiovasculaire

ANAMNÈSE

- Poser les questions clés relatives à l'anamnèse cardiovasculaire.

Troubles cardiaques, HTA, rhumatisme articulaire aigu, souffles cardiaques, douleur ou gêne thoracique, palpitations, dyspnée, orthopnée, dyspnée paroxystique nocturne, oedèmes, anciens ECG ou autres résultats tests
Douleur thoracique : DD angine de poitrine, infarctus du myocarde, anévrisme disséquant de l'aorte.

Facteurs de risques CV : HTA, diabète, dyslipidémie, obésité, antécédents familiaux, tabac

- Décrire et reconnaître les symptômes des principales pathologies cardiovasculaires.

- Palpitations
- Essoufflement : orthopnée et/ou dyspnée paroxystique nocturne
- Oedèmes

- Face à une plainte de douleur thoracique, rechercher les symptômes en faveur d'une origine cardiaque ou extra-cardiaque.

1. Cardiaque

Coronaires: Angine de poitrine, infarctus du myocarde

Douleur intense, souvent intolérable avec angoisse et sensation de mort imminente, svt irradiations Durée prolongée (> 20'), résistante à la nitroglycérine sublinguale

Extra-coronaires: Péricardite (*atténuation par la position penchée en avant, augmentée à l'inspiration*) Dissection de l'aorte (*Douleur brutale qui évoque un infarctus..«Déchirure antéro-postérieure», puis dos, pouvant descendre dans les lombes, associée à une modification des pouls périphériques +++ / asymétrie tensionnelle*)

2. Pulmonaire

Embolie pulmonaire (*Douleur latéro-thoracique ou basi-thoracique, «point de coté» augmentée à l'inspiration, Signes d'accompagnement ? : toux, tachypnée, hémoptysie...*)

Pneumonie aiguë (*Le contexte est évocateur, associant des signes d'infection, une toux expectoration et des anomalies à l'auscultation*)

3. Digestives

Reflux gastro-oesophagien, Cholécytite, Pancréatite

4. Pleurales

Pneumothorax droit complet (*douleur aiguë brutale avec inhibition de la respiration en «coup de poignard» puis tend à s'estomper, la dyspnée apparaît secondairement puis domine le tableau clinique*) Epanchement pleural

5. Pariétales

Contusion par la ceinture de sécurité, fractures de côtes

6. Psychogène

(*Localisation variable d'un épisode/ interrogatoire à l'autre Caractères atypiques de la douleur Patient angoissé !*)

SIGNES CLINIQUES

- Reconnaître et interpréter les principaux signes cliniques de pathologie cardiovasculaire.

INSPECTION: Opérations, cicatrices, déformation, cyanose

PALPATION :

1. Pouls et TA
2. Veines jugulaires
 - Ondes a absentes dans la FA Ondes v proéminentes dans l'insuffisance tricuspide
 - PVJ élevée IC droite ; PVJ abaissée dans l'hypovolémie

3. Pouls carotidien
 - Retardé dans la sténose aortique ; bondissant dans l'insuffisance aortique
 - Souffle carotidien suggère un rétrécissement athéroscléreux
4. Choc de pointe (localisation, diamètre, amplitude, durée)

AUSCULTATION :

1. Cœur,
 - B1
 - B2, *dédoublement physiologique (inspiration) pathologique (expiration)*
 - Bruits surajoutés dans la systole, *clicks systoliques*
 - Bruits surajoutés dans la diastole, *B3/ B4*
 - Souffles systoliques, *méso-/holo-/télé-systoliques*
 - Souffles diastoliques, *proto-/méso-/télé-diastoliques*

- **Identifier et interpréter les bruits cardiaques pathologiques les plus fréquents**

ANOMALIE DES BRUITS PHYSIOLOGIQUES

ÉCLAT DU PREMIER BRUIT: sclérose valve mitrale ou RM

ÉCLAT DU DEUXIÈME BRUIT: HTA, Htp

ASSOURDISSEMENT GLOBAL DES BRUITS: épanch. pleuraux/péricardiques, ICC, infarctus du myocarde.

- Diminution de l'intensité du **1er** bruit fait partie de l'ensemble auscultatoire de **l'insuffisance mitrale** (I.M.).
- Diminution de l'intensité du **2ème** bruit **rétrécissement aortique** (RA) et **rétrécissement pulmonaire** (RP)

DÉDOUBLEMENT DE B1 ET DE B2 : Bloc de branche

DÉDOUBLEMENT DE B2: Large et fixe quel que soit le temps respiratoire : s'observe dans la C.I.A.

ADJONCTION DE BRUITS ANORMAUX

BRUITS DIASTOLIQUES: galop : bruit sourd, diastolique

- Galop protodiastolique (par accroissement du remplissage rapide initial)
- Galop présystolique (par accroissement du remplissage rapide terminal)
- Galop de sommation: au milieu de la diastole

BRUITS SYSTOLIQUES :

- Click mésotélésystolique: situé au milieu ou à la fin de la systole, bruit méso ou télé systolique. Il précède souvent une petite insuffisance mitrale télé systolique (prolapsus mitral).
- Claquement protosystolique d'éjection : contemporain de l'ouverture des sigmoïdes aortiques ou pulmonaires, témoigne d'une sclérose des valves

SOUFFLES

INTENSITÉ :

- 1/6 = très faible
- 2/6 = faible mais facilement perçu
- 3/6 = moyenne
- 4/6 = forte avec frémissement
- 5/6 = très forte
- 6/6 = entendu à distance du thorax (quelques centimètres)

TIMBRE

CHRONOLOGIE

FOYER MAXIMUM

IRRADIATIONS

SOUFFLES ORGANIQUES : Correspondent à une lésion des orifices valvulaires:

- sont constants, situés à un foyer déterminé

- se propagent dans une direction précise : irradiation
- timbre est franc
- s'accompagnent souvent d'un frémissement :

INSUFFISANCE MITRALE

Situé à la pointe et irradiant dans l'aisselle,

- il est doux, en jet de vapeur, parfois plus rude
- il occupe toute la systole, allant d'un bruit à l'autre: holosystolique
- il s'accompagne d'un affaiblissement de B 1 à la

RÉTRÉCISSEMENT AORTIQUE

Situé au foyer aortique, il est rude, râpeux; il irradie dans les vaisseaux du cou, mais aussi à la pointe où devient plus intense et change de timbre, devenant souvent musical.

- occupe le milieu de la systole, bien détaché de B 1 et B 2 : mésosystolique.
- s'accompagne d'un affaiblissement, ou d'une disparition, de B 2 au foyer aortique

INSUFFISANCE AORTIQUE

Situé au foyer aortique mais fréquemment entendu au foyer pulmonaire et le long du bord gauche du sternum (foyer aortique accessoire)

- est diastolique, accroché à B 2 et décroissant durant la diastole
- est "doux, lointain, humé, aspiratif" de faible intensité, de tonalité élevée ; il irradie le long du bord gauche du sternum (foyer aortique accessoire)

ROULEMENTS

ROULEMENT DU RÉTRÉCISSEMENT MITRAL

S'entend à la pointe et dans l'aisselle. En décubitus latéral gauche et surtout après effort.

Il débute par le claquement d'ouverture et se renforce avant le B1 suivant (renforcement présystolique).

Le renforcement présystolique du roulement disparaît lorsque le patient est en arythmie par fibrillation auriculaire.

ROULEMENT DE FLINT DE L'INSUFFISANCE AORTIQUE

S'entend à la pointe, en fin de diastole ; accompagne les insuffisances aortiques importantes

FROTTEMENTS

FROTTEMENT PÉRICARDIQUE

Bruit superficiel, semblant très près de la membrane du stéthoscope, mésocardiaque. Il est très localisé, sans irradiation (naît et meurt sur place).

Il respecte les bruits du cœur :

- soit mésosystolique,
- soit mésodiastolique,
- soit aux deux temps,

réalisant un bruit de va et vient caractéristique.

Il peut être intense, rugueux (crissement de cuir neuf), ou discret (froissement de la soie).

Il persiste en apnée, mieux entendu en inspiration en décubitus dorsal, en expiration en position assise.

2.1.3 Système pulmonaire

ANAMNÈSE PULMONAIRE

- **Poser les questions clés relatives à l'anamnèse pulmonaire.**

Il est important d'aborder différents points et de ne pas les oublier :

Toux, expectoration (couleur, quantité), hémoptysies (caractériser son importance, stries, qté modéré, massive = urgence vitale), douleur thoracique, dyspnée (la caractériser (NYHA) selon les 4 stades, question des rampes d'escalier, questionnaire de la qualité de vie), sifflements, pleurésie, dernière RX thorax. ATCD asthme (allergique ou non), fumée. Ne pas oublier non plus de poser les questions relatives à l'anamnèse actuelle : si douleur la caractériser, caractériser le symptôme, établir une échelle temporelle, manifestation associé, traumatisme récent, etc.

Ne pas oublier de toujours exclure les urgences vitales : dissection aortique, infarctus du myocarde, tamponnade, embolie pulmonaire et pneumothorax. Les urgences cardiaques sont aussi à exclure car les symptômes peuvent se confondre. Les douleurs thoraciques peuvent également venir du système digestif, des muscles, des articulations, du système nerveux et des tissus cutané et sous-cutané. De plus certains symptômes respiratoires ne viennent pas du système pulmonaire mais ont une origine ORL (sinusite → toux ; obstruction VAS → dyspnée ; épistaxis → hémoptysies).

CARACTERISER DIFFERENTS SYMPTOMES :

Dyspnée : depuis quand, aggravation ou diminution, permanent ou intermittent, diurne ou nocturne, facteurs favorisants (position, effort, froid, poussière, pollens, animaux,) et phénomènes associés (sifflements, toux douleur, fièvre).

Toux : ancienneté, expectoration (couleur) ou sèche, circonstance (rythme dans la journée, position, effort, lors de repas, etc.), signes associés (respiration sifflante, râles crépitants, toux rauque, fièvre).

Douleur pleuropulmonaire : pneumothorax, pleurésie, embolie pulmonaire, cancer pulmonaire infiltrant, mésothéliome pleural, trachéobronchite (douleur accentuée par la toux, les autres c'est par la respiration).

Troubles respiratoires du sommeil : ronflements, sensation d'étouffements, réveils répétés.

- **Décrire et reconnaître les symptômes des principales pathologies pulmonaires.**

OEDEME PULMONAIRE : tachypnée et orthopnée, râles crépitants sur les plages pulmonaires et SaO₂ (air ambiant) < 90%. Mousse dans les voies respiratoires et dans la bouche, toux, cyanose, asphyxie suivie d'angoisses.

PNEUMOTHORAX : toujours exclure le pneumothorax sous tension qui est une urgence médicale (si on le suspecte on doit prendre une seringue 20mL avec 10mL de NaCl, piquer en médio-claviculaire 2eic et voir si on peut aspirer de l'air facilement (tester l'emplacement de l'aiguille en aspirant gentiment tout en enfonçant la seringue) si c'est le cas on retire la seringue et l'aiguille fait office de drain le temps qu'on en pose un). Les symptômes sont dyspnée et tachypnée, douleur thoracique respiro-dépendante et une toux sèche. A la percussion le tympanisme est accentué, le murmure respiratoire diminué.

PNEUMONIE : peut-être suspectée en présence de toux aiguë, anomalie des paramètres vitaux. Avec une symptomatologie d'infection des VAI et fièvre de plus de 4 jours. Une dyspnée ou une douleur thoracique peuvent souvent être associés à un état fébrile en cas de pneumonie et chez les personnes âgées il y a régulièrement une baisse de la fonctionnalité et un état confusionnel. Mais lorsque la pneumonie est suspectée il faut faire une RX pour la

confirmer. Le plus souvent bactérienne et dans 30 % des pneumonies acquise en communauté c'est le pneumocoque l'identifié. Et dans 20-65% on n'identifie pas le germe.

BPCO : déclin progressif et irréversible de la fonction pulmonaire. Expectorations presque tous les jours (plus de 3 mois par année au moins 2 ans consécutifs), dyspnée à l'effort. Si sévère : thorax en tonneau, percussion hypersonore, murmure diminué, signes d'insuffisance cardiaque D, de polyglobulie, cyanose centrale.

SIGNES CLINIQUES

- **Reconnaître et interpréter les principaux signes cliniques de pathologie respiratoire.**

INSPECTION

CYANOSE : apparaît lorsque le sang capillaire contient environ 50g/L d'Hb réduite. Donc anémie : cyanose atténuée ou absente, polyglobulie : cyanose accentuée. Donc toujours le corrélér avec le taux d'Hb. Elle peut être centrale : langue et ongles bleus, $\text{SaO}_2 < 85\%$ et résulte d'une maladie pulmonaire ou d'un shunt cardiaque D-G, ou périphérique : langue rose, ongles bleus, $\text{SaO}_2 > 85\%$ et peut venir d'une insuffisance cardiaque ou d'un choc (diffuse) ou de troubles vasculaires (localisée).

HYPERCAPNIE : les signes sont transpiration (tête et front principalement), céphalées (vasodilatation intracrânienne), somnolence et état confusionnel (carbonarcose = œdème cérébral) et astérisis.

FREQUENCE RESPIRATOIRE : (à prendre sur 30sec ou 1 min) $< 10/\text{min}$ = bradypnée, $> 20/\text{min}$ = tachypnée. Attention $\neq$ à la ventilation alvéolaire (hyper- ou hypoventilation, la PCO_2 en est l'indicateur) ! Vérifier si apnée ou respiration périodique (Cheyne-Stokes : alternance entre hyperpnée et apnée par diminution progressive des mouvements thoraciques menant, lors d'IC grave ou de lésions neurologiques du diencephale).

MORPHOLOGIE DU THORAX :

- Thorax en tonneau : fibrose chronique donnant une diminution de la force de rappel du thorax il devient donc rond. Visible de l'extérieur et en RX : trop d'air en avant du cœur.
- Asymétrie, cyphose, scoliose, cyphoscoliose.
- Thorax en entonnoir (pectus excavatum), ou en carène (pectus carinatum).

MOUVEMENTS RESPIRATOIRES : physiologique couché prédominance abdo, assis prédominance thoracique (réflex maintenant en place le contenu abdominal).

Mouvements anormaux à rechercher en position couchée : prédominance thoracique (muscles inspiratoires accessoires), paradoxe abdominal (creusement de l'abdomen à l'inspiration notamment lors de dysfonction ou paralysie du diaphragme), paradoxe thoracique (normalement thorax et abdomen sont en expansion à l'inspiration, là il y a une saillie de l'abdomen mais une dépression du thorax, lors de maladies neuromusculaires atteignant les muscles intercostaux mais pas le diaphragme).

PALPATION

MOUVEMENTS RESPIRATOIRES : vérifier la symétrie et l'expansion thoracique.

CONTRACTIONS DES MUSCLES INSPIRATOIRES ACCESSOIRES : comme les scalènes (peu visibles mais palpables) et les sternocléidomastoïdiens).

ADENOPATHIES : signes possibles de tumeur.

EMPHYSEME SOUS-CUTANE : en appuyant on sent les bulles, les tissus mous et lâches se gonflent. Visible à la RX thorax avec bras en extension.

DOULEURS LOCALISEES : qu'il faut localiser précisément grâce à la palpation.

PERCUSSION PULMONAIRE

Le son normal étant intermédiaire [entre le tympanisme (estomac vide) et la matité (foie, loges lombaires)] et propre aux poumons. Le tympanisme signifierait une distension pulmonaire ou un pneumothorax, la matité un épanchement pleural ou une condensation pulmonaire.

- Identifier et interpréter les principaux bruits respiratoires pathologiques.

BRUITS NORMAUX :

Bruit trachéal : on entend les deux temps de la respiration c'est un souffle relativement fort. Ce sont les turbulences au niveau de la trachée qui génèrent le bruit. Le passage dans les cordes vocales et la réflexion sur les parois de la trachée génèrent le flux turbulent.

Bruit trachéo-bronchique : il est de plus faible intensité que le bruit trachéal et légèrement plus grave.

Murmure respiratoire : se situe sur la totalité des plages pulmonaires. Il est encore un peu plus faible en intensité et est légèrement plus fort à l'inspiration qu'à l'expiration. Il faut le comparer sur les différentes plages pulmonaires.

BRUITS ANORMAUX :

Souffle tubaire : signe d'une pneumonie, c'est un bruit trachéal ou trachéo-bronchique à un endroit inhabituel. C'est donc la localisation à l'auscultation qui est pathologique. Cela signifie que le parenchyme pulmonaire a perdu de son élasticité et augmente donc l'intensité du murmure respiratoire.

Râles crépitants fins : on les retrouve lors d'inflammation du parenchyme pulmonaire (alvéolite, fibrose, œdème). C'est certainement l'ouverture et la fermeture des petites voies aériennes qui toutes ensemble forment le crépitement. Présent uniquement à l'inspiration.

Râles crépitants grossiers : ils sont présents lors d'excès de sécrétions bronchiques. Ils sont à nouveau principalement inspiratoires. Si l'on demande au patient de tousser, les crépitants se modifient, changent de place contrairement aux crépitants fins.

Sibilances : caractérisent les obstructions bronchiques ou l'asthme. L'expiration est prolongée et c'est à ce moment que l'on entend le bruit. Il peut parfois déborder sur l'inspiration. C'est un son et non pas un bruit. Il a une fréquence bien déterminée (400Hz). L'effet sifflant vient de la vibration lors du flux expiratoire des parois des VAI qui sont contractées.

Ronchi : Présents dans la bronchite (dont BPCO) et l'asthme. Ils correspondent aux sibilances mais sont de plus basse fréquence et touchent les voies aériennes de plus gros calibre.

- Décrire la technique de la mesure du débit expiratoire de pointe (peak flow), décrire les indications à cet examen, et en interpréter les résultats.

MESURE DU DEP : inspiration complète, expiration forcée immédiate et maximale, il faut éviter les fuites d'air et la toux durant l'examen. Retenir la plus haute valeur de 3 manœuvres. Les normes étant : femmes 300-500L/min, hommes 400-700L/min, ceci dépendant de la taille et l'âge en plus du sexe. Si pathologique il faut faire une spirométrie. Si normal ça permet d'éliminer certains diagnostics.

INDICATIONS A L'EXAMEN :

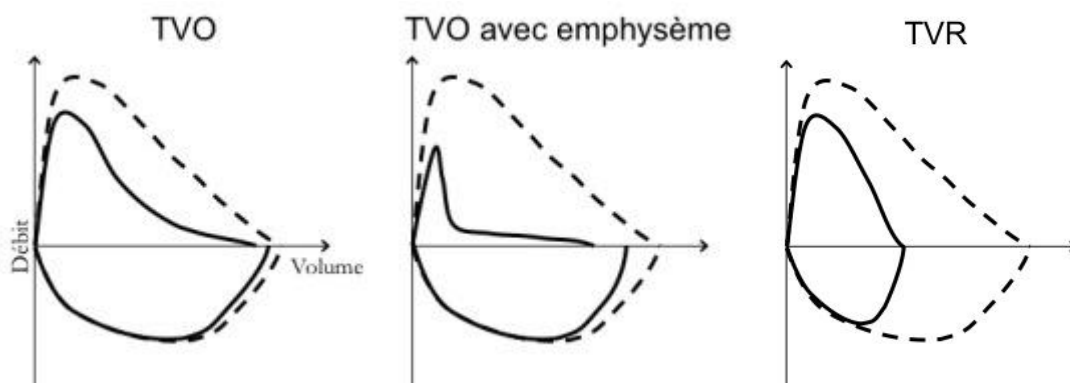
Asthme : pour le suivi du patient, débitmètre portable permet au patient de contrôler son souffle, et d'adapter le traitement en fonction d'un plan prédéterminé avec le médecin.

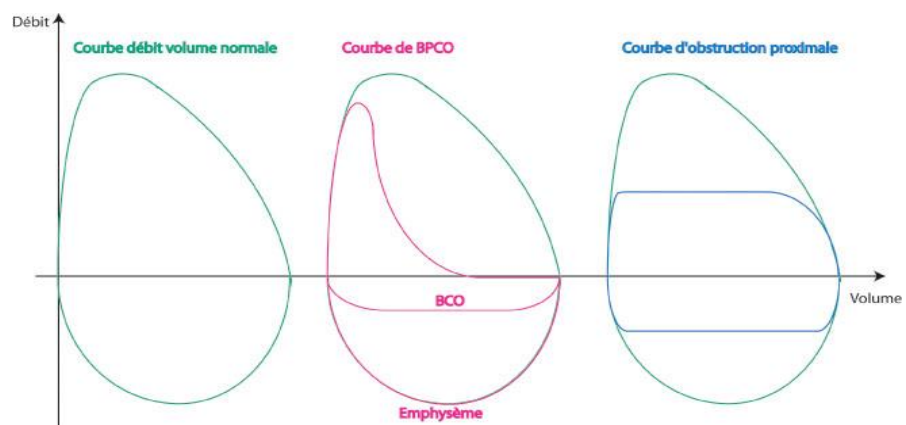
BPCO : est exclu par un DEP normal. Sinon peu recommandé car sous-estime la gravité du syndrome obstructif.

INTERPRETATION DES RESULTATS :

TVO = trouble ventilatoire obstructif

TVR : trouble ventilatoire restrictif, les rapports entre débits et volumes sont normaux. VEMS/CV (ou rapport de Tiffeneau si l'expiration est lente et non forcée) est normal.





2.1.4 Système digestif, nutrition, proctologie

ANAMNÈSE

- Mener une anamnèse alimentaire et nutritionnelle simple.
- Connaître les spécificités nutritionnelles des personnes âgées.
- Rechercher, à l'aide d'une anamnèse dirigée, les symptômes de troubles digestifs.

Question ouverte « Décrivez-moi cette douleur/ce trouble ? »

Compléter les informations récoltées, caractériser la douleur/le trouble (7 items) :

1. Localisation, Irradiation
2. Qualité
3. Intensité : sur une échelle de 1 à 10
4. Chronologie
5. Conditions de survenue
6. Facteurs modifiants
7. Manifestations associées

Symptômes associés (fièvre, perte d'appétit, nausées, vomissements, régurgitations, anorexie : pourquoi ? Intolérance à certains aliments ou par crainte d'avoir mal, diarrhée, constipation, ballonnement, nausées, pyrosis, remontées acides, hydratation, plénitude abdominale, dysphagie (= peine à avaler): des liquides ? Solides ? Des deux ? Intermittente ou permanente ? Odynodysphagie (=douleur à la déglutition), flatulences, ictère

Vomissements : couleur, odeur, volume approximatif, sang (hématémèse : sang rouge)

Selles : fréquence, aspect, difficulté à aller à selles, changements mélaena (selles noires), rectorragies

Diarrhées : selles trop hydriques ou volumineuses (pas seulement aspect!), durée, volume, fréquence, consistance, mucus, sang, douleur, crampes, nuit ?, grasses, malodorantes, traitement en cours (antibio, médecine alternative), voyage récent, régime alimentaire, immunité

Constipation : moins de 3x par semaine, ou plus de défécations avec efforts, sensation d'évacuation incomplète -> fréquence, émission douloureuse, selles dures
Solutions essayées ? Médicament ou stress ? Troubles systémiques ?

DOULEUR ABDOMINALE HAUTE ET CHRONIQUE :

Ballonnement, nausées, pyrosis (sensation de **brûlure** partant du creux de l'estomac et remontant vers la bouche, pouvant s'accompagner de régurgitations alimentaires involontaires. C'est un signe quasiment spécifique de **reflux gastro-œsophagien**)

RGO : pyrosis, remontées acides, ou régurgitations -> plus d'une fois par semaine Parfois symptômes respiratoires et pharyngés : toux, sifflement, pneumonie d'inhalation, enrouement, mal de gorge chronique

DOULEUR ABDOMINALE BASSE AIGUË

Appareil uro-génital : douleurs sus-pubiennes, ou du flanc

Calcul rénal : douleur aiguë type colique (intermittente) du QID ou QIG

Appendicite : douleur QID, migrant à partir de la région péri-ombilicale, associée à une contracture de la paroi abdominale à la palpation, fièvre modérée

Divericulite : douleur au QIG avec masse palpable

Occlusion intestinale: arrêt des matières et des gaz, abdomen silencieux, ferme, non dépressible ou douloureux à la décompression,

DOULEUR ABDOMINALE BASSE CHRONIQUE

Douleur d'origine gynécologique : y penser chez les femmes

Cancer côlon : modification fonctionnement intestinal (diarrhée, constipation, ...) et masse

Intolérance au lactose : diarrhée, flatulences, douleur abdo.

Syndrome de l'intestin irritable : douleurs intermittentes pendant 12 semaines au cours de l'année précédente, soulagées par la défécation ou accompagnée par des diarrhées et/ou constipation

- Identifier dans une anamnèse les plaintes digestives/abdominales ayant une origine extra digestive.
- Mener une anamnèse proctologique.

SIGNES CLINIQUES

Examen clinique de l'abdomen :

Position du patient : couché avec les 9 quadrants visibles (= déshabillés), détendu, jambe légèrement pliée (evt coussin sous genoux) et abdomen bien éclairé

OBSERVATION :

- Allure de l'abdomen (symétrie, plat, gonflé, arrondi, protubérance, couleur de la peau -> ictère)
- Cicatrices, lésions cutanées, hernies, bleus (hématome, hémorragie), vergetures ? (5)
- Mouvements : respiratoires, péristaltiques, pulsatiles

AUSCULTATION (toujours avant palpation) : Des 4 quadrants : écouter les bruits :

- Cliquetis, gargouillis -> normal
- Bruits augmentés -> diarrhées, début d'occlusion intestinale
- Bruits diminués -> Iléus paralytique, péritonite
- Bruits métalliques -> iléus mécanique ?

PERCUSSION des 4 quadrants

- Tympanisme : prédomine en situation normale (gaz) (si abdo proéminent et uniquement tympanique -> occlusion intestinale)
- Matité : due aux liquides, matières, organes

Recherchez matité du foie en suivant la ligne médioclaviculaire à droite et le tympanisme de la poche d'air gastrique à gauche, ainsi qu'une éventuelle splénomégalie en suivant la ligne médio-axillaire g.

PALPATION des 4 quadrants :

Commencer par là où le patient n'a PAS mal, regardez son visage (réactions, mimiques)

- Superficielle : voir si résistances, douleurs, masses
- Profonde : délimiter, caractériser une éventuelle masse, une défense / détente (signe d'irritation péritonéale)

Détente : Appuyer profondément comme à la palpation, et relâcher brusquement

Signe de Mc Burney : Le point de Mc Burney (M) est un point situé au tiers externe de la ligne reliant l'épine iliaque antéro-supérieure droite à l'ombilic. S'il est douloureux à la palpation, c'est un signe d'appendicite.

Signe de Rosving : on appuie profondément avec le poing fermé sur le QIG, on retire notre main d'un seul coup. Si le patient a mal au QID quand on retire la main : signe positif.

Signe du psoas : demander au patient de fléchir la hanche, alors qu'on oppose une résistance sur sa jambe. Signe positif si douleur en FID. Utile pour appendice rétro-caecal.

FOIE/ RATE/ REINS

Main g. sous le patient pour soutenir, puis palper foie avec main droite

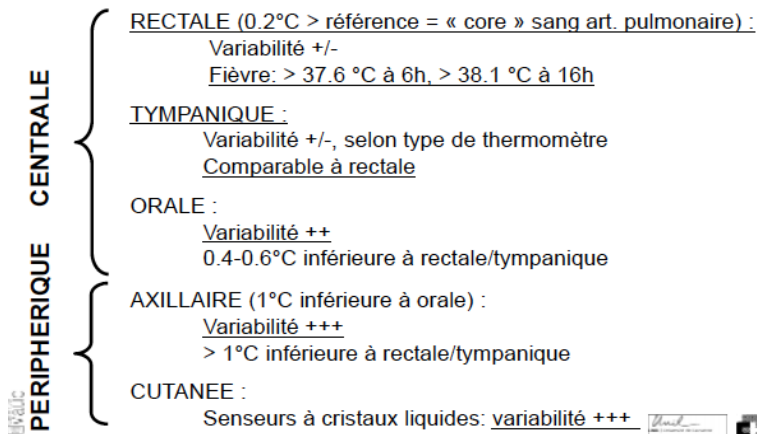
Signe de Murphy : mettre ses 2 mains doigts « en crochet » sous les côtes à droite, les doigts appuyés en direction du foie, demander au patient de faire une inspiration profonde. S'il a mal brusquement quand il inspire, c'est un signe de cholécystite.

Toucher rectal : dire qu'il fait partie de l'examen abdominal

2.1.5 Pédiatrie

ETAT FEBRILE OU INFLAMMATOIRE

21) Connaître la technique de mesure de la température corporelle et savoir interpréter cette dernière.



Aspects Pratiques :

- Rectale : Insertion adéquate, $> 3-4$ cm
- Tympanique : Nettoyage du conduit auditif. Viser le tympan avec le faisceau infra-rouge
- Orale : Sous-lingual, fermer les lèvres (pas possible chez patient inconscient, agité, non collaborant, ...) ↑ fumée, mastication, inflammation, ↓ resp. rapide, glace.
- Axillaire : Attention, ça bouge !

Thermomètre (Type/Temps de mesure) :

- Mercure 5 à 15 min, multiples lectures séquentielles
- Electronique 10 à 60 sec.
- Calibration.

Interprétation :

Hypothermie chez sujets sains : personne âgée/peu mobile, alcool, malnutrition, hiver.

Hyperthermie chez sujets sains : ovulation/grossesse/ménopause, digestion, activité physique, été.

Définition de la fièvre : $1x > 38.5^{\circ}\text{C}$ **ou** $2x > 38.0^{\circ}\text{C}$.

22) Enumérer les éléments anamnestiques et cliniques d'une fièvre d'origine infectieuse et non infectieuse

Maladie fébrile : Que demander au patient ?

Anamnèse générale

DIMINUTION DES DEFENSES : infections récidivantes, anomalies anatomiques/fonctionnelles, maladies chroniques, immunosuppression.

EXPOSITION DANS L'ENVIRONNEMENT : malades/personnel soignant, nourriture/eau/air/ animaux.

VOYAGES/ORIGINES : exposition/mesures préventives.

VACCINATIONS/ALLERGIES (ANTIBIOTIQUES !).

MALADIES INFLAMMATOIRES.

Fièvre d'origine infectieuse :

- Timing de la fièvre : durée ? périodicité ?
- Anamnèse familiale / personnelle d'infections récidivantes (prédisposition génétique) ?
- Etat des défenses immunitaires ?
 - Maladies chroniques ?
 - Anomalies anatomiques / fonctionnelles ?
 - Immunosuppression ?
- Expositions dans l'environnement ?
 - Contacts avec malades / soignants ?
 - Contacts avec animaux (profession / loisirs) ?
 - Conditions environnement privé / professionnel ?
 - Voyages ? Origine ?
- Foyer ? Symptômes/signes spécifiques à chaque organe/système ?

Drapeaux rouges : (a) Immunosuppression sévère -> sepsis fulminant (b) Hypotension/ tachycardie -> sepsis sévère/choc septique (c) Insuffisance respiratoire (d) Atteinte SNC +/- lésions cutanées hémorragiques (e) Souffle cardiaque nouveau +/- signes de dissémination hématogène (f) Infections sévères sans fièvre ! (personne âgée, immunosuppression, ...).

Fièvre d'origine non infectieuse : maladies inflammatoires dans la majorité des cas

Anamnèse générale

- Malaise, asthénie
- Symptômes B : fièvre (prolongée) +/- frissons, perte poids, sudations nocturnes.
- Vasculites auto-immunes
- Connectivites (collagénoses) auto-immunes
- Arthrites / Arthropathies microcristallines ...
- Fièvres auto-inflammatoires (périodiques)

Anamnèse systémique

Systèmes/Organes « nobles » = importance vitale : cœur, poumons, reins, digestif, système nerveux

Systèmes/Organes évidents, mais « négligés » :

- Peau (érythème, pâleur, cyanose, ulcères, nécroses ...)
- Yeux (sécheresse, rougeur, douleurs, troubles visuels ...)
- ORL (sécheresse, aphtes, ulcères, rhinorrhée, épistaxis ...)
- Ostéo-articulaire (arthrite(s), tendinite, synovite, type d'articulation et localisation ?)

Comment distinguer des fièvres infectieuses et non-infectieuses ?

Anamnèse + Status, y c. identifier danger vital

Escalade diagnostique séquentielle d'examen complémentaires : formule sanguine (+/- CRP / PCT), cultures (+/- sérologies +/- PCR), bilan immunologique (Elispot, auto-anticorps,), imagerie (Rx, US, CT, IRM, ...), biopsies (cultures, PCR, histo/immunopathologie, ...).

Hygiène hospitalière

23) Connaître et motiver les mesures de base en matière d'hygiène hospitalière

Principaux axes de prévention

- **Processus de soins** respectant les règles d'hygiène. Ex. asepsie lors de gestes invasifs
- Lutte contre la **transmission** de microorganismes:
 - Précautions standards (toujours)
 - Mesures additionnelles (parfois)
- **Surveillance**, débouchant sur des mesures de **contrôle** si nécessaire

Précautions standards : Principe :

Tout contact avec la peau, les muqueuses, du sang, des liquides biologiques, des sécrétions, des excréments (sauf la sueur), l'environnement immédiat du patient est une occasion de transmission d'agents infectieux.

S'adressent à tout le personnel soignant.

S'appliquent à tout patient.

Rubriques:

- **Hygiène des mains** : friction avec une solution hydro-alcoolique Alternative : lavage avec un savon antiseptique.
 - Avant tout contact avec un patient
 - Après tout contact avec un patient
 - Avant un acte aseptique
 - Après contact avec des objets dans le voisinage immédiat du patient
 - Après contact avec liquide biologique, muqueuse, ou peau lésée / après retrait des gants
 - Le port de gants ne change rien à ces indications.
- Utilisation du matériel de protection (masques, gants, lunettes, surblouses)
- Traitement du matériel médical, des déchets, du linge
- Entretien de l'environnement
- **Protection du personnel** (pratique sécurisée des injections, vaccination)
- Protection des patients

24) Justifier l'existence de mesures additionnelles dans des situations spécifiques.

But: renforcer les précautions standard pour interrompre la chaîne de transmission des infections

Indications: lorsque cette chaîne pose des problèmes particuliers:

- Pathogène multi-résistant : traitement plus difficile
- Pathogène très contagieux : risque d'épidémie
- Mode de transmission non couvert par les précautions standard
- Pathogène très virulent

Précautions de contact :

- Chambre individuelle si possible
- Blouse de protection et gants
- Désinfection accrue de l'environnement

Précautions "gouttelettes"

- Précautions de contact
- + masque chirurgical
- + protection oculaire

Précautions "aérosols" (ou: "air")

- Masque ultra-filtrant
- Chambre filtrée en pression négative
- + précautions de contact

Pathogène	Précautions		
	Contact	Gouttelettes	Air
MRSA	●		
<i>Clostridium difficile</i>	●		
Influenza virus		●	
Méningocoque		●	
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>			●
Varicella zoster virus	●		●

25) Appliquer les règles d'hygiène hospitalière dans la pratique hospitalière.

2.1.7 Urgences -Marine

Situations d'urgence

1) Connaître et savoir réaliser l'ABC primaire et secondaire.

ABCDE PRIMAIRE : permet une évaluation rapide et un rétablissement immédiat des fonctions vitales.

- A = Airways - vérifier les voies aériennes : une obstruction (obstacle ou compression extérieure) / lésion primaire (trauma maxillo-facial/cou/larynx/trachée) ou secondaire (coma, relâchement du tonus de la musculature buccale, paralysie, etc.)
- B = Breathing : concerne la qualité du système thorax-poumon, donc les échanges gazeux. Une pathologie peut toucher les bronches ou les poumons (pneumonie, BPCO, asthme), des traumatismes (pneumothorax, plaie perforante, hémithorax, etc.) ainsi qu'une aspiration ou un OAP peuvent également affecter cet échange gazeux.
- C = Circulation. C'est-à-dire le cœur et les vaisseaux. Un problème dans ce système peut donner lieu à un collapsus vasculaire. Soit par perte volumique soit par défaillance mécanique. Penser que beaucoup de sang peut être stocké dans les différentes parties du corps (cuisse, poumon, etc.). Lors de fracture sur os

périphérique, l'immobilisation va stopper l'hémorragie. En cas d'accident de la route il vaut mieux appeler le chirurgien pour permettre une prise en charge rapide si rupture de la rate (hémorragie massive).

➔ Étiologie des chocs (circulation inefficace) : hémorragie (attention aux fractures ! fémurs et bassin) ou non hémorragique : pneumothorax, tamponnade, cardiogène, neurogène (atteinte du SNC souvent si trauma crânien), septique, anaphylactique.

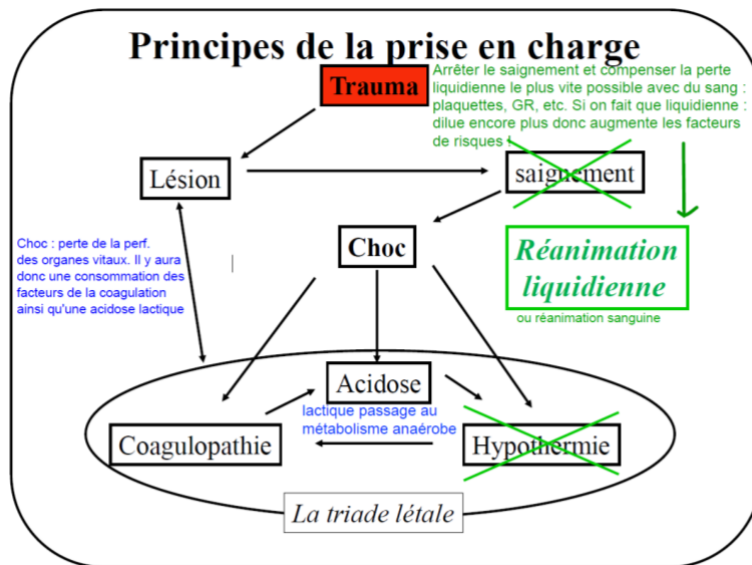
- D = Disability ou Défibrillation : donc en cas d'atteinte neurologique centrale le plus souvent.

➔ Etiologie des comas : traumatique, métabolique, toxiques, AVC, Autres.

Glasgow coma scale (GCS) : mesure la réponse oculaire (aucune 1 à 4 spontanée), verbale (aucune 1 à normale 5) et motrice aux ordres ou à la douleur (aucune 1 à suivie 6). Coma = GCS < 6. Il faut toujours tester le réflexe pupillaire en cas de suspicion de coma !

- E = Exposure ou Environnement : température, regarder le patient en le retournant (voir l'entier du corps). Ne pas oublier en cas d'accident à bord d'un véhicule 4 roues que la désincarcération peut être longue. L'hypothermie est catastrophique chez un traumatisé = facteur d'aggravation. Il faut donc réchauffer le patient et en urgence (transfusion chauffées, couvertures chauffantes).

ABCDE SECONDAIRE : faire une réévaluation ABCDE mais cette fois associée à quelques examens ciblés. Permet de cibler



les désordres menaçant la vie qu'ils soient d'origine médicale, traumatique ou toxique.

- A : VA libres avec canule de Guedel (tube semi-rigide en forme de « ? » introduit dans les VA d'un patient pour les maintenir ouvertes), O2 et minerve.
- B : inspection, auscultation, oxymétrie et RX thorax
- C : réévaluation TA aux 2 bras, FC, T°C, perfusion périphérique, mise en place de 2 voies veineuses, cristalloïde chaud (soluté de perfusion contenant des particules de petite taille (sels minéraux et glucose) donc sortent rapidement de la circulation pour aller dans les tissus, l'effet recherché est donc lié à leur osmolalité), labo, ECG (12 pistes pour nombre d'extra-systoles ventriculaires (ESV) et voir si abaissement de ST), médicaments éventuels
- D : réévaluation GCS et pupilles, défibrillateur prêt, examen neurologique ciblé, RX cervicales, CT scan et EEG.
- E-exposition : inspection complète du patient (log-roll souvent impossible en ABCDE primaire car il faut une surveillance et vérifier le déplacement possible du patient) et prévention/traitement de l'hypothermie.
E-environnement : anamnèse actuelle, ATCD, contexte et allergies.

En résumé : ABCDE primaire, secondaire (avec examens ciblés : labo, RX) et finalement un examen complet (évaluation secondaire) et des examens complémentaire (CT, EEG).

2) Adapter la prise de l'anamnèse au contexte de l'urgence.

Cibler l'anamnèse actuelle, le contexte et les événements ayant amené à la consultation (redéfinir l'échelle temporelle en s'aidant des proches), vérifier les antécédents en premier lieu personnels puis familiaux. Et surtout ne pas oublier les allergies afin d'assurer une prise en charge hospitalière adéquate.

Ne pas oublier lors du premier contact de dire bonjour, de se présenter calmement, d'établir un contact (visuel/physique/verbal) avec le patient et de s'excuser pour l'attente. Si le patient répond ABCD primaire est OK. Le patient doit pouvoir s'exprimer car ses premiers mots seront les plus importants en situation d'urgence, car ils exprimeront ce qui est le plus important pour lui.

3) Décrire la prise en charge clinique précoce d'une situation d'urgence telle qu'une douleur thoracique ou une dyspnée aiguë.

Immédiatement après l'arrivée du patient : ABCD si ABC sont ok le D n'est pas nécessaire. Exécuter le tout dans l'ordre permet de ne pas sauter une étape potentiellement importante et d'avoir un langage commun avec toute l'équipe soignante. Puis ABCD secondaire (vérifier A, O₂ pour B, monitoring et accès veineux pour C et D = diagnostic différentiel. En 3^{ème} on passe à l'Anamnèse et à la caractérisation de la plainte/douleur. Puis les examens Complémentaire et enfin le soulagement de la Douleurs. Le premier examen urgent en cas de douleur thoracique est l'ECG !

- ➔ Si sous décalage ST : infarctus ! Attention ECG donne aussi une idée de la localisation et du territoire vasculaire atteint ! Il faut aussi rapidement soulager les douleurs (morphine) car elles activent le SNA et augmente la fréquence cardiaque donc le travail et les besoin en O₂. Traitement initial : aspirine et dérivés nitrés.

Conclusion : traitement en cas d'infarctus : **M**(orphine)**O**(xygène)**N**(itrés)**A**(aspirine).

Après la mise en place d'un traitement initial, on passe au STATUS il faut rechercher les signes de défaillance cardiaque (turgescence jugulaire, reflux hépato-jugulaire, auscultation cardiaque, auscultation pulmonaire.

Suite du traitement : anticoagulation, thrombolyse et angioplastie percutanée (donc SI et cardiologue). Si avant la prise en charge par le cardiologue prend du temps il est possible que le patient perde conscience. Direct au déchoc car cœur ischémique = cœur arythmogène.

Patient en choc : ne répond pas, inconscient, ne respire pas, absence de pouls. Dans ce cas on commence par C (si on trouve quelqu'un sans l'avoir suivi avant on commence par A), si pas de pouls BLS. Le défibrillateur indique selon le rythme s'il faut ou non choquer. Le patient n'est pas forcément inconscient pour un rythme choquable (TV) si FV le patient est inconscient. ABCD primaire = BLS, le secondaire : A : intubation, B : assurer la ventilation et ascension du thorax symétrique (si ok vérifier FR), C : accès IV, déterminer le rythme, donner médicaments appropriés, D = DD : chercher et traiter les causes réversibles. Mesure avancée : ttt anti-arythmique.

- ➔ En cas de dyspnée la procédure est semblable mais moins critique (souvent pas d'intubation immédiate, mais prise de FR), auscultation, étude des paramètres vitaux, prise de sang, hémoculture, cultures d'expectoration et Rx thorax. Attention si le patient ne respire plus ou vraiment mal : choc, embolie pulmonaire, etc. Et surtout ne pas banaliser les étiologies infectieuses ! Plus la prise en charge est rapide (antibiotiques) plus l'espérance de guérison est grande (notamment pneumonie personnes âgées).

Il faut donc grâce à l'ABCD primaire et secondaire trier l'urgent et le moins urgent. Ne pas hésiter à revenir pour compléter une anamnèse ou une auscultation, rapidement choisir les examens complémentaires afin de pouvoir au plus vite instaurer un traitement et surtout réévaluer régulièrement la situation !

4) Identifier les éléments anamnestiques et cliniques signant la gravité/ l'urgence d'un syndrome douloureux abdominal aigu.

En premier lieu : anamnèse, puis examen physique ! Il faut toujours voir le patient avant de prescrire un CT ! Dans l'anamnèse il faut chercher les choses, les infirmières ont déjà fait une petite anamnèse lors du tri on a donc une idée de la situation, il faut donc préciser et être sûr de ne pas manquer d'information importante ! Il ne faut jamais oublier de caractériser une douleur ou une plainte. Il existe des douleurs agonique (hyper-intense dès le début, par exemple : AAA rompu, appendicite, perforation gastrique ou torsion testiculaire ou ovarienne), progressive (diverticulite, pyélonéphrite ischémie du mésentère ou cholecystique) ou variable (colique digestive, néphrotique ou biliaire). Si aggravation avec le mouvement = péritonite.

L'irradiation : dans l'épaule c'est souvent une pathologie sous-diaphragmatique, dans le dos du pancréas ou dissection/anévrysme aortique et dans la hanche souvent situé dans le rétropéritoine ou la FID/FIG.



A l'anamnèse : inappétence/perte pondérale, nausées, modification du transit, soif, accompagné de symptôme urinaire ou gynécologique, état général, ATCD chirurgicaux.

Les signes clés sont les signes vitaux et le score de Glasgow. Un ventre gonflé peut l'être de : graisse, d'un fluide, de gaz, d'un fœtus, de selles ou d'une masse tumorale. Si c'est liquide on peut le faire bouger !

Examen clinique :

→ Inspection : du pubis aux tétons ! Cicatrice, mvts respiratoires, distension, douleurs avec mvts/toux (Valsalva), péristaltisme visible, hématomes, cellulite, asymétrie. Il ne faut pas oublier d'inspecter l'état général du patient, déshydratation/œdèmes, cyanose, hypoperfusion périphérique, confusion, anxiété, moiteur, tachypnée.

→ Palpation : ex, défense en superficiel, etc. Recherche de masse pathologique (profonde/superficielle, pulsatile ou non, organe/structure dilaté ou nouvellement formé, etc.). Attention le but n'est pas d'augmenter les douleurs !

Il faut aussi toujours vérifier s'il y a des hernies (encore plus si le patient est obèse).

→ Auscultation : tonalité, fréquence, bruits surajoutés, attention aux souffles vasculaires !!!

→ Touché rectal/vaginal (appelé la gynécologue)

Examens paracliniques :

Stix urinaire et test de grossesse. Prise de sang (év. Test hépatiques et pancréatiques), gazométrie (suspicion d'ischémie), US abdo (liquide, calculs, masses), RX thorax debout (air sous-diaphragmatique) RX abdo couché (anses dilatées, mégacolon, coprostase).

Traitement initial : selon 3 axes : oxygénation, hydratation, analgésie.

Facteurs confondants : âge avancé, ttt corticostéroïdes, diabète, ascite, HIV + (non traité), baisse de l'EC, antalgie profonde.

Décision finale : ttt immédiat nécessaire ou non chirurgical ou conservateur, laparoscopie exploratrice au préalable, hospitalisation ou non (si conservateur), investigations et réévaluation si diagnostic pas clair.

5) Reconnaître les valeurs éthiques en jeu dans une situation de refus de soins chez un patient nécessitant un traitement urgent.

Prendre en compte les principes d'éthique de base comme l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice. L'élément clé dans le refus de soins est la capacité de discernement. C'est aussi un élément clé dans la relation avec le patient. Le patient jouit d'office de sa capacité de discernement, il faut donc prouver la capacité et non l'incapacité. Néanmoins au niveau médical le principe peut être nuancé par le TF, si un patient psychiatrique a une incapacité de discernement suspectée d'emblée (comme en cas de retard mental). Le MMS (mini-mental state) permet d'estimer la probabilité de ne pas avoir sa capacité de discernement. Néanmoins les patients ont souvent appris à compenser. Ils donnent des sortes de pseudo-réponses, c'est pourquoi les médecins ne reconnaissent l'incapacité de discernement que dans 42%.

Capacité de discernement : prise de conscience et assimilation de l'information, manifestation de sa volonté et l'exprimer librement. La question de la religion est aussi importante car elle prend une grande place dans le choix des patients.

ACRONYME : DECISION

D : déterminer s'il y a besoin d'établir la capacité de discernement. Parler et examiner son patient et son apparence.

Examiner son lieu de vie.

E : établir la capacité à communiquer volontairement. Il accepte le dialogue, parle librement, se fait comprendre.

C : corriger les facteurs environnementaux, métabolique, mentaux, physique qui peuvent alter la capacité de discernement. Problème de santé, médicaments, toxiques.

I : investiguer d'éventuels troubles de l'humeur ou une baisse des capacités intellectuelles par des tests standards. Emotions, démence, état confusionnel.

S : sonder les buts, les valeurs et les craintes du patient. Quantité vs qualité de vie, soins de confort vs agressivité thérapeutique, peurs liées au traitement.

I : intégrer les informations recueillies.

O : ouvertement informer le patient et ses proches. Information objective, donner les résultats, ne pas initier des démarches sans que tout le monde soit au courant de la décision prise par le médecin.

N : noter scrupuleusement les éléments pertinents de votre évaluation dans le dossier médical. Importance médico-légale, noter les personnes présentes lors de la discussion.

ACRONYME : CURVES

C : choose and communicate

U : understand

R : reason

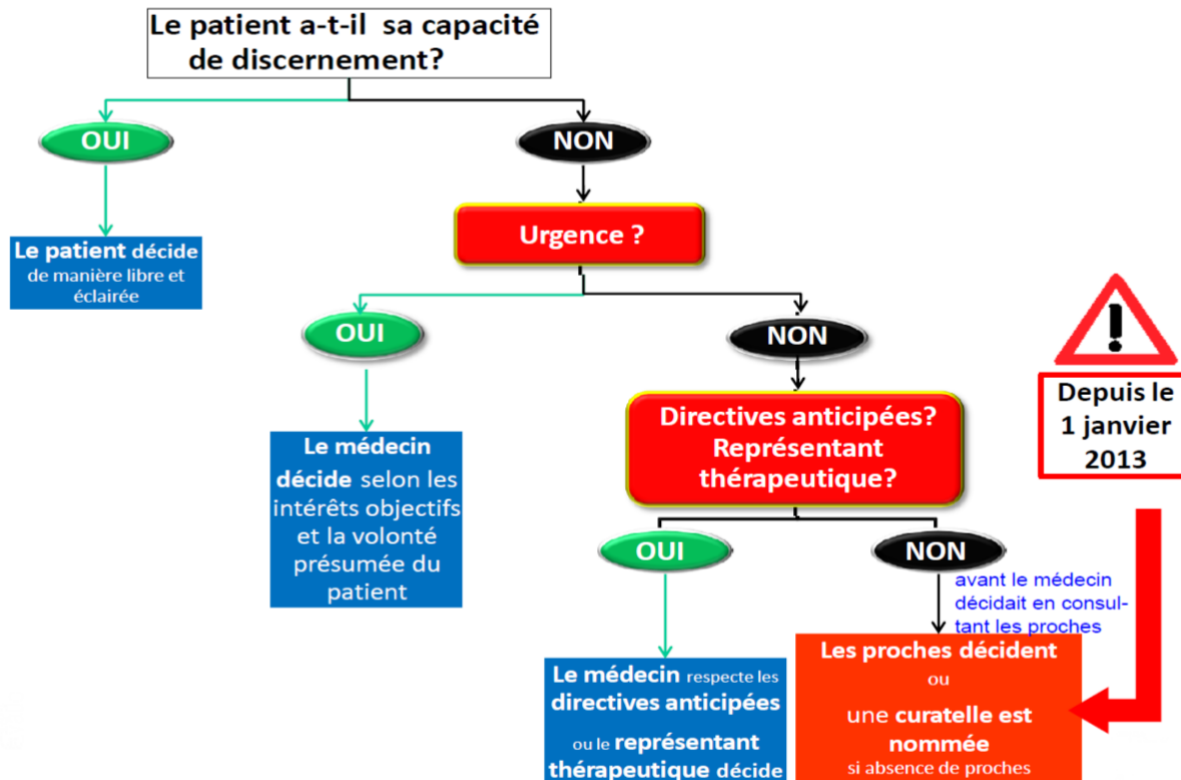
V : value

E : emergency (risque imminent)

S : Surrogate (représentant thérapeutique, légal ou proche à contacter).

Hiérarchisation des représentants du patient incapable de discernement : personne désignée, curateur, conjoint ou partenaire enregistré, personne faisant ménage commun avec la personne et qui lui fournit assistance régulièrement, descendant, père et mère, frères et sœurs. Pour tous les derniers représentants cités c'est uniquement s'ils lui fournissent une assistance régulièrement.

Attention plus les conséquences sont importantes plus il faut augmenter son niveau de certitude sur la capacité de



discernement. Cette dernière peut également être trompeuse car elle évolue rapidement au cours du temps et peut être différente selon le niveau de gravité de décision. Mais pour une situation donnée et un moment précis le patient a ou non sa capacité de discernement.

En conclusion le refus de soins peut exprimer la volonté légitime d'un patient compétent mais peut également être l'expression inadéquate d'un patient sans capacité de discernement.

Il faut prendre en compte qu'autour du médecin urgentiste et de ces compétences médicales il y a la déontologie, les lois, l'éthique et la société en générale, tous participant, plus ou moins, à l'évaluation de la capacité de discernement.

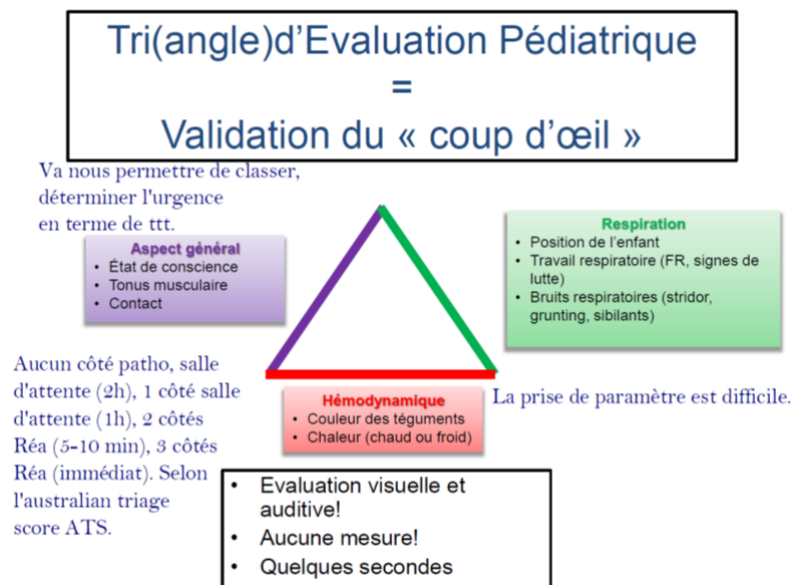
6) Mener une anamnèse en situation d'urgence pédiatrique.

Il faut prendre en compte les parents de l'enfant. Ils le connaissent parfaitement, s'il le trouve différent de d'habitude les écouter, ils ont souvent raison et le pédiatre se trompe régulièrement. Il faut néanmoins faire attention à ce que l'enfant (s'il est en âge de parler) puisse s'exprimer de lui-même et ensuite aller chercher un avis complémentaire chez les parents. Les enfants en pré-adolescence ou adolescence devraient être vu seul un moment pour qu'ils se sentent libres d'aborder tous les sujets et de répondre aux questions du médecin. Connaître les lois de protection des mineurs pour savoir comment réagir en cas de suspicion de maltraitance infantile.

7) Evaluer le degré d'urgence en pédiatrie

Il faut identifier les situations à risque sur deux plans : signe respiratoires, circulatoires ou cardiaque (arrêt) mais aussi sur l'impression initiale (conscience, respiration couleur). Savoir quand commencer une réanimation cardio-pulmonaire (RCP) (si absence de pouls ou <60/min et mauvaise perfusion malgré ventilation et O2 adéquates).

La séquence pour la prise en charge aux urgences pédiatriques est l'impression initiale immédiatement suivi de la séquence : évaluation (primaire, secondaire et tests diagnostics), identification, intervention.



Le triage se fait également parfois par téléphone : ambulance, consultation rapide ou juste des conseils.

ABCDE pédiatrique :

A : l'examen doit permettre de décider si libres, libres avec « aide » ou si nécessitent une ventilation en pression positive.

B : FR lutte, bruits, couleur de peau, oxymètre. Attention le saturomètre ne dit pas quelle quantité d'O₂ est délivrée ni la capacité d'extraction de l'O₂ dans les tissus. Mesurer FR palpée, comptée, monitoring, et saturomètre. Et faire attention car ne donne pas d'indication sur l'efficacité de la ventilation.

CLASSIFICATION : normal, DR = détresse respiratoire, augmentation du travail respiratoire = dyspnée, IR = oxygénation ou ventilation inadéquate = « manque d'oxygène ».

C : - perfusion cutanée, fonction cardiaque (pouls cendraux et périphérique, FC, TA), perfusion d'organe (cerveau, reins, peau).

CLASSIFICATION : signes précoces (compensé) FC augmenté et mauvaise perfusion périphérique, signes tardifs (décompensé) pouls centraux faibles et diminution de l'état d'éveil, hypoTA (difficile en pédiatrie). Pouls centraux : fémoral (difficile), brachial (<12 mois) carotidien (>1 an), axillaire.

D : score de Glasgow simplifié : éveillé, réponse à la voix, réponse à la douleur, sans réponse.

État des pupilles.

E : regarder l'entier du corps : marqu de trauma, brûlure, hémorragie. T°C (auriculaire ou rectale), maintenir au chaud l'enfant, attention à la colonne cervicale si trauma supposé.

CATEGORISER MALADIE PAR TYPE ET SEVERITE



Problème respiratoire

- **Sévérité:**
 - Détresse respiratoire
 - Insuffisance respiratoire
- **Type:**
 - Obstruction haute
 - Obstruction basse
 - Maladie pulmonaire
 - Contrôle respiration

Problème circulatoire

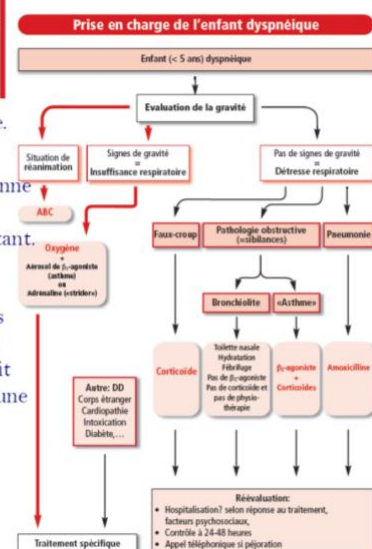
- **Sévérité:**
 - Choc compensé
 - Choc décompensé
- **Type:**
 - Hypovolémique
 - Distributif
 - Cardiogénique
 - Obstructif

RESPIRATOIRE + CIRCULATOIRE

= Insuffisance cardiorespiratoire (respiration agonale, bradycardie, cyanose, Mauvaise perfusion et état d'éveil diminué)

Si pas d'insuffisance respiratoire, on doit essayer d'aller plus loin dans le diagnostic de la détresse respiratoire.

Distinguer la pneumonie bactérienne des pathologies sifflantes est important. Tant qu'on a des sifflements, on est dans les pathologies obstructives, plutôt virale. Rare qu'on ait des sibilances avec une pneumonie.



Approche ABC + : A + immobilisation cervicale, B + penser pneumothorax et DR, C + contrôler hémorragie, arythmies, hypoTA, ischémie coronarienne (intox cocaïne).

HEXAGONE PEDIATRIQUE : SAMPLE : **S**igns et symptoms, **A**llergies, **M**édications, **P**ast médical history, **L**ast meal, **E**vents leading to présentation.

Les examens complémentaires sont rarement capital ou essentiel mais selon la situation on peut envisager des tests semblables à la médecine d'urgence d'adulte.

APPLICATIONS : attention : nourrisson ne respire pas spontanément, donc donner de l'O₂ mais ventiler en même temps. Quand on n'arrive pas à piquer l'enfant on peut utiliser l'intra-osseuse, pratique pour aborder l'enfant mais attention très douloureux.

L'intubation se fait par voie nasale chez le petit enfant. Attention utilisé un matériel adapté en taille.

2.1.8 Neurologie Signes cliniques - Savoir réaliser l'examen des nerfs crâniens (Romaine)

ECOS – Les nerfs crâniens

I : LE NERF OLFACTIF

- ✓ Boucher la narine en plaçant le doigt dessous (et non déplacer la cloison nasale) en mettant une odeur sous l'autre

II : LE NERF OPTIQUE (→ VISION)

- ✓ Enlever lunettes si le patient en porte
- ✓ Tester le champ visuel : on confronte notre champ visuel à celui du patient en cachant d'une main un œil et en faisant des mouvements à équidistance entre le patient et nous
- ✓ Test de vue (comme chez l'ophtalmo ; dont le but n'est pas de détecter une myopie mais une déficience du nerf)

III : LE NERF OCULOMOTEUR (Attention : ces tests comprennent aussi ceux des nerfs IV et VI impliqués dans les mouvements oculaires)

- ✓ Rappel : il innerve tous les muscles des yeux sauf l'oblique supérieur (IV) et le droit latéral (VI). Il innerve en plus de cela le muscle releveur de la paupière, le muscle ciliaire et le muscle constricteur de l'iris
- ✓ Les pupilles sont-elles isochores ? On accepte 0.5 mm de Δ
- ✓ Test du réflexe pupillaire : avec une main placée au niveau du nez (pour séparer les deux yeux), on teste le réflexe ipsilatéral ET consensuel (= controlatéral)
- ✓ Y a-t-il une ptose palpébrale ?
- ✓ Demander au patient s'il a une diplopie
- ✓ Test de la poursuite / convergence
- ✓ Test des nystagmus : on place une main de chaque côté en levant un doigt d'un côté puis de l'autre et on demande au patient de fixer le doigt levé

V : LE NERF TRIJUMEAU

- ✓ Piquer-toucher : ophtalmique (au-dessus du sourcil), maxillaire (pommette), mandibulaire (menton, attention pas en dessous !)
- ✓ Réflexe cornéen = réflexe de défense des yeux (le patient cligne). Enlever le coton utilisé pour le toucher et former une pointe très fine. Appuyer la main sur le visage pour éviter de crever les yeux du patient s'il bouge. PIEGE : pas de réflexe cornéen si le patient a des lentilles de contact !
- ✓ Test moteur : muscles masseter, temporal (on demande au patient de mâcher)

VII : LE NERF FACIAL = MIMIQUES

- ✓ Vérifier la symétrie : soulever/froncer les sourcils, fermer les yeux et tester la résistance, montrer les dents, sourire, gonfler les joues. Si c'est unilatéral, on soupçonnera plutôt une atteinte périphérique. Les atteintes centrales peuvent sembler moins « graves » (le front se plie, etc)

VIII : LE NERF VESTIBULO-COCHLEAIRE

- ✓ Cochléaire (=ouïe) : tester les deux côtés en plaçant nos mains par derrière et en faisant de petits bruits de chaque côté. Faire les tests de Weber (placer sur vortex) et Rinné.
- ✓ Vestibulaire (=équilibre) : regarder s'il y a un nystagmus spontané et faire la manœuvre de Halmagyi (tourner la tête du patient en lui demandant de fixer un point)

IX : LE NERF GLOSSO-PHARYNGIEN

- ✓ Ecouter la voix du patient, lui demander si elle a changé
- ✓ Réflexe de Gag (= réflexe d'avaler) : demander au patient d'avaler, vérifier la montée du pharynx.
- ✓ Examiner la luette du patient qui dévie du côté non pathologique !!! (à cause de l'activité du muscle élévateur du voile du palais)

X : LE NERF VAGUE : examiné avec le IX, sinon surtout voies autonomes

XI : LE NERF ACCESSOIRE

- ✓ Vérifier la force du trapèze et du sterno-cléido-mastoïdien

XII : LE NERF HYPOGLOSSE

- ✓ Ecouter la prononciation du patient
- ✓ Demander au patient de tirer la langue : la déviation se fera du côté pathologique !

2.1.10 Sexologie et urologie - Amélie

anamnèse urogénitale et sexologique

commencer par dire au patient qu'il est libre de répondre ou non aux questions qu'on va lui poser.

Respecter ses convictions, ses valeurs et sa religion. L'assurer de la confidentialité de l'entretien et du but diagnostique de nos questions.

1. identifier si le problème, s'il est de l'ordre de
 - l'excitation (les troubles du désir étant les + fréquents)
 - éjaculation précoce
 - atteinte de l'orgasme
 - douleurs aux rapports
 - désir d'enfant

2. Caractérisation du problème

- émergence du problème (problème lié au partenaire? contraception? perte désir après naissance enfant ? effet 2' d'un médicament ? ménopause ? désir d'enfants ? pratique ? initiative ? phantasmes ? préférences?...)
- maladie somatique ? (très souvent cause de problème d'excitation chez l'H : diabète, HTA, maladie NRL...)
- fréquence et variations
- durée, intensité, conséquences (comment le couple vit-il cela ? angoisses?)
- facteurs aggravants et atténuants.

3. Brève anamnèse biographique

- famille d'origine, religion, développement : traumatisme (viol, abus) ? regard sur soi ? Rapport par rapport au corps, regard sur autrui
- éducation et représentations personnelle de la sexualité / pratiques sexuelles.
- relation avec les parents, éducation sexuelle : vécu de la puberté et des 1ères expériences .
- communication au sein de la famille & avec le partenaire
- Relations extraconjugales ?
- très important : évaluer désir, plaisir et satisfaction NON sexuelle à investiguer . souvent révélateur par exemple d'une éventuelle anhédonie ou d'un autre problème (psychiatrique?) sous-jacent. Parler des problèmes au sein du couple.

Status

1. savoir effectuer un examen des loges rénales :
 - ⚡ Palpation bimanuelle : une main postérieure dans le flanc, l'autre main palpe antérieurement sous le rebord costal. Le rein descend lors de l'inspiration profonde. Le pôle inférieur du rein droit est parfois palpable chez le sujet normal.
 - ⚡ Percussion des loges rénales (patient en position assise) à la recherche d'une douleur. (pyélonéphrite)

2. DECRIRE l'examen de l'appareil uro-génital masculin

observation très importante : EG, pilosité, inspection de l'abdomen

symétrie, position et taille des testicules, varicocèle, phimosis, excroissance, signes inflammatoires...

l'examen se poursuit par une palpation des testicules à la recherche d'une masse ou d'une douleur.

en cas de palpation anormale . TR

ou selon ce qu'on relève et suspecte : stix urinaire, culture, US ; CUM, biopsie...

3. DECRIRE l'examen de l'appareil uro-génital féminin (=du périnée)

inspection : peau péri-anale et périnéale, sous vêtements sales ? fissure, marisques, thrombose péri-anale, prolapsus rectal, abcès, selles

TR : Masse ? selles dans l'ampoule rectale ? sphincter : longueur, symétrie (jms de remarques sur le tonus)

Puis, selon suspecté : Anuscopie, Rectoscopie, US anale, défécographie standard (assis RX), IRM-défécographie, manométrie pour le volume et la compliance, et capacité du rectum.

2.1.11 Appareil locomoteur **anne**

Anamnèse

- 1) **Mener une anamnèse de l'appareil locomoteur.**

Type d'affection dont souffre le patient

- Maladies ostéo-articulaires mécaniques : traumatiques et dégénérative

- Maladies infl :
- maladies thumatologiques infl
- maladies systémiques à expression rhumatologique
- Tr fonctionnels

Douleur = Plainte la plus fréquente et commune

Svt très caractéristique : nociceptive, neuropathique, psychogène

- Douleur infl : nocturne, de repos, réveils nocturnes, raideur matinale, amélioration par l'activité
- Douleur méc : douleur d'utilisation, diurnes, dérouillage mais pas de raideur, aggravé pas mvt
- QUAND : mode de début, horaire, durée, évolution, facteurs déclenchant ou associées

OU : Monoart, polyart (au moins 5 articulations) oligo (>1/<5 articulations de moyenne ou grande taille sinon pauciarticulaire) ; Distribution et pattern ; local, irradiation, à distance

Vraiment articulaire ? ☐ musculaire ou osseuse ? viscérale ?

POURQUOI : Fonction, qualité de vie ; traumatisme ; fièvre ; Etat général ; Boiterie ; Handicap ; Signes d'infection (chaleur, tuméfaction, rougeur)

- Anamnèse familiale
- Anamnèse systémique ☐ maladies systémiques avec manif rhumatologiques ou malades rhumatologiques infl qui sont des maladies systémiques

Signes cliniques

2) Réaliser un status articulaire (main, genou, pied).

Pied

- Inspection : Couleur, tuméfaction, Déformaton, Hyperkératose, Lésions cutanées (Examineur plus bas que le pat)
- Palpation

Pouls (température, pouls pédieux, tibial post)

Nerfs ☐ sensibilité, tinel canal tarsien, nerf tibial

Zones cibles ☐ tendons fibulaires, t. tibial ant et post, T achille ; têtes métatarsiennes

- Mvt
- flexion 30-50°, extension 10-15° ☐ Flexio-neutre-extension (30-0-10)
- inversion (supination) 20°, eversion (pronation) 5°
- rot int 10°, rot ext 10°

- Laxité/stabilité
- Force musculaire
- Axe des membres
- Angle du pas : 15°
- Cycle de la marche

Appui bipodal ☐ Axe arrière pied normal = 5° valgus ; Podoscope : 1/3-2/3

Appui monopodal ☐ normal = réduction en varus

- Orteils en griffe, hallux valgus, ongle incarné, quintus varus

3) Examiner la démarche d'un patient et reconnaître les boîtiers principales (Trendelenburg, Duchenne)

Demander patient de marcher qq mètre puis tourner et revenir vers vous

☐ regarder mvt des bras

Trendelenburg : tenir sur un pied ☐ regarde stabilité du bassin (crêtes iliaques) ; insuffisance moyen fessier si pas stable

4) Décrire et reconnaître les déformations et postures fréquentes, en particulier au niveau des membres inférieurs et du rachis.

- Position de la tête
- Equilibre ceinture scapulaire + omoplates
- Rebord costal, flancs et crêtes iliaques
- Triangle thoraco-brachial
- Varus/valgus
- recurvatum

GALS - Amélie

Commencer par poser les 3 questions de dépistage qui sont les suivantes :

- 1) Avez-vous des douleurs ?
- 2) Etes vous capable de monter et descendre les escaliers ?
- 3) Etes vous capable de vous habiller tout seul ?

L'examen se fait torse nu idéalement, en short et pieds nus.

on commence par demander au patient de marcher une aller retour. on va observer

- ⤴ ballant des bras
- ⤴ boiterie
- ⤴ posture
- ⤴ façon de se retourner

Inspection :

1. face au patient : bras tendus avec paumes face a nous
 - ⤴ angle des coudes
 - ⤴ difformités des genoux et des pieds
2. Dos du patient
 - ⤴ hauteur des épaules et des omoplates
 - ⤴ symétrie des crêtes iliaques
 - ⤴ colonne : droite ? (scoliose?)
 - ⤴ rectangle formé sous les bras : doit être semblable ddc
 - ⤴ mollets : hypertrophiques ?
3. de coté
 - ⤴ position de la tête
 - ⤴ normalement : lordose cervicale et lombaire et cyphose dorsale et sacrée
 - ⤴ Genoux : flexion/hyperextension ? (genou en recturvatum fréqu chez les JF)
 - ⤴ Voûte plantaire (pieds plats?difformités?)
 - ⤴ mesurer distance doigts-sol et évaluer la flexion lobaire en même temps (avec 2 doigts)

Redemander au patient de se mettre face à nous.

1. Mobilité colonne : inclinaisons latérales et rotation de la nuque
2. articulation temporale-mandibulaire : demander de bouger la mâchoire a G/D
3. Epaules : demander de mettre les 2 mains derrière la tête (évalue l'abduction et la rotation externe en même temps)
4. Mains et poignets : demander d'effectuer une pronation et supination.

muscles : atrophie des éminences thénar/hypothénar? (palper!)

force : patient doit fermer sa main autour de notre doigts (« gripping »)

mouvements fins: demander qu'il touche chaque doigt à son pouce

articulaire : « squeezing » des articulations MCP (trop mous lors de arthrite rhumatoïde)

Puis, coucher le patient sur le dos a 180°

1. hanche et genou : flexion passive, rotation interne
2. genou : test du glaçon
3. pieds : observer dessous si callosités (suggestifs d'une démarche anormale)

« squeezing » de l'articulation MTP

2.1.12 Dermatologie **anne**

Lésions élémentaires primaires

Macule

- Tâche colorée sans relief (lésion plane)
- Couleur : Rouge → érythème (s'efface à la vitropression), purpura ; Blanc → dépigmentée ; Brun → hyperpigmentée

Papule

- Lésion surélevée solide par augmentation focale de masse du tissu
- <0,5 cm

- Distinction :
épidermique ⇨ limites nettes (folliculaire ou non folliculaire ⇨ verrues);
dermique ⇨ limites moins nettes, par œdème (urticaire), par infiltrat dermique infl ou tumoral
- Papule épidermique
Papule dermique inflammatoire
Papule dermique tumorale

Nodule >0.5 cm

Kyste : lésion semi-solide « fluctuante » à la palpation (en profondeur de la peau)

Vésicule et bulle

- Soulèvement circonscrit de l'épiderme contenant un liquide clair ou hémorragique
Vésicules <0,5cm
Bulles >0,5cm ⇨ intraépidermiques : fragiles (croûte se forme ⇨ protection) ; sous épidermiques : solides

Pustule

- Lésion circonscrite contenant du pus
⇨ folliculaire : centrée par un poil (point d'entrée pour l'infection) ; non-folliculaire

Lésions élémentaires secondaires

Croûte

- Coagulation à la surface de la peau d'un exsudat
Séveux ⇨ à partir de vésicule
Purulent ⇨ à partir de pustule
Hématique ⇨ à partir de plaie

Croûte mellicérique

- = Impétigo
- en lien avec streptocoque pyogenes et/ou S.aureus
- Prendre en sérieux ! aussi infection dans d'autres organes ! drainage vers l'intérieur ⇨ cerveau !

Squame traduisent une augmentation de l'épaisseur de la couche cornée

- Lames de couches cornées qui se détachent de la peau
- L'aspect de la squame est spécifique du processus pathologique : psoriasiforme (petite ; tâches de bougies), Ichtyosiforme, Scarlatiniforme (+ imp en taille ; vaste nappe rouge vif, sans espace de peau saine), Pityriasiforme (microsquame)

Pertes de substance

Erosion : superficielle

- Perte plus ou moins importante de l'épiderme
- Guérison sans cicatrice
- Erosion arrondie avec croûtes : il y avait une bulle avant

Ulcère : profond

- Perte de substance s'étendant au derme
- Résulte d'un traumatisme ou d'une nécrose
- Guérison avec formation d'une cicatrice

Rhagade (fissure) : linéaire

Atrophie

- Perte de substance avec épiderme normal ou cicatrisé

Cicatrice hypertrophique

- cicatrices qui se sont épaissies au cours de la période de guérison, mais qui ne dépassent pas le bord de la plaie initiale. Elles finissent normalement pas diminuer quelque peu, mais sur une plus longue période qu'une cicatrice normale. (Chéloïde: s'étend aux tissus voisins)